

LA CLAVICULE

PLAN :

I-OBJECTIFS.

II-INTRODUCTION.

III-MISE EN PLACE.

IV-ANATOMIE DESCRIPTIVE :

A-FACE SUPERIEURE.

B-FACE INFERIEURE.

C-BORD ANTERIEUR.

D-BORD POSTERIEUR.

E-EXTREMITE EXTERNE.

F-EXTREMITE INTERNE.

I-OBJECTIVES.

II-INTRODUCTION.

III-IMPLEMENTATION.

IV-DESCRIPTIVE ANATOMY:

A-UPPER SURFACE.

B-LOWER SURFACE.

C-ANTERIOR EDGE.

D-POSTERIOR EDGE.

E-EXTERNAL END.

F-INTERNAL END.

I-OBJECTIFS :

1-Mise en place.

2-Reconnaitre les faces, les bords ainsi que les insertions musculaires.

3-Décrire les épiphyses.

4-Intérêt clinique.

1-Setup.

2-Identify the surfaces, edges, and muscle insertions.

3-Describe the epiphyses.

4-Clinical significance.

II-INTRODUCTION :

Os long, pair et non symétrique, situé à la partie antéro-supérieure du thorax, complétant en avant la ceinture scapulaire, la clavicule s'étend du sternum à l'acromion.

La clavicule est contournée en S italique. Elle présente deux courbures :

- l'une médiale : concave en arrière ;
- l'autre latérale : concave en avant.

Elle présente à décrire : 2 faces, 2 bords, 2 extrémités.

A long, paired, asymmetrical bone located in the anterior-superior part of the thorax, completing the anterior part of the shoulder girdle, the clavicle extends from the sternum to the acromion.

The clavicle has an italic S-shaped contour. It has two curves:

- *one medial: concave at the back;*
- *the other lateral: concave at the front.*

It has two faces, two edges and two ends.

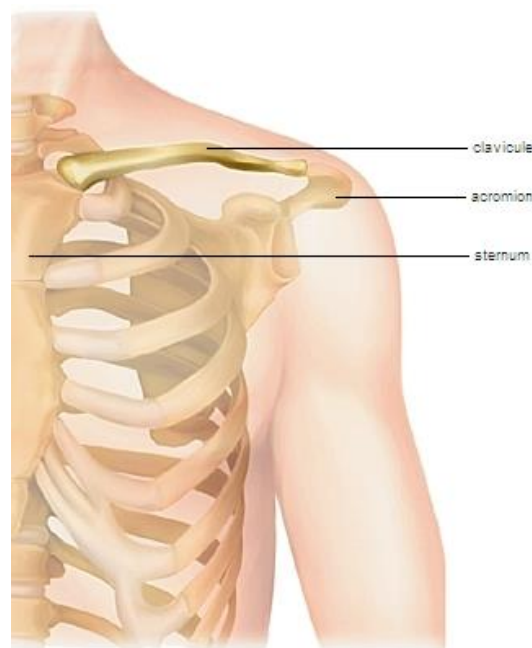


Fig. 1 : la clavicule.

III-MISE EN PLACE :

- en bas, la face parcourue par une gouttière.
- en dehors, l'extrémité aplatie.
- en avant, le bord concave de cette extrémité.

IV-ANATOMIE DESCRIPTIVE :

A-FACE SUPERIEURE :

CLAVICULE

Présente quelques rugosités sur lesquelles s'insèrent :

- le muscle sterno-cléido-mastoïdien en dedans.
- le muscle deltoïde en dehors et en avant.
- le muscle trapèze en dehors et en arrière.

III-POSITIONING:

- at the bottom, the side with a groove.
- on the outside, the flattened end.
- at the front, the concave edge of this end.

IV-DESCRIPTIVE ANATOMY:

A-UPPER SURFACE:

Presents some roughness on which are inserted:

- the sternocleidomastoid muscle on the inside.
- the deltoid muscle on the outside and front.
- the trapezius muscle on the outside and back.

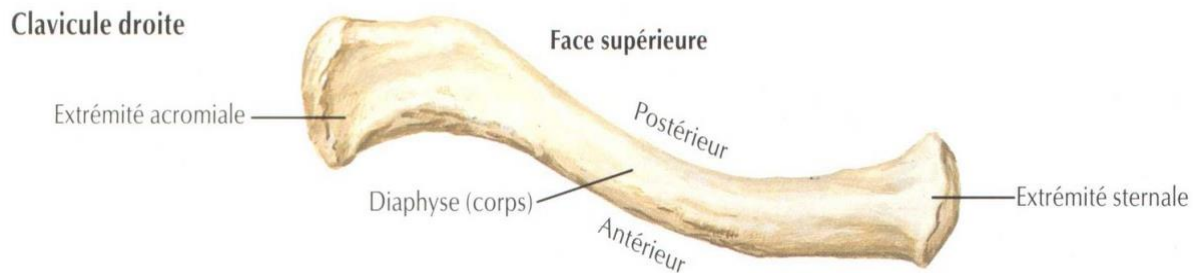


Fig2 : *clavicule droite face supérieure.*

B-FACE INFÉRIEURE :

-Dans sa partie moyenne, la face inférieure est creusée par une dépression ; c'est le sillon du muscle subclavier.

Dans la partie moyenne de cette face se trouve le foramen nourricier de l'os.

-A l'extrémité médiale de la face inférieure se trouve l'empreinte d'attache du ligament costo-claviculaire.

-A l'extrémité externe se trouve la ligne trapézoïde qui comprend 2 segments ; l'un antérieur, donne attache au ligament trapézoïde ; l'autre postérieure occupée par une saillie appelée tubercule conoïde qui donne insertion au ligament conoïde.

INFERIOR SURFACE:

-In its middle part, the lower surface is hollowed out by a depression; this is the subclavian muscle groove.

In the middle part of this surface is the nutrient foramen of the bone.

CLAVICULE

-At the medial end of the lower surface is the attachment site of the costoclavicular ligament.
-At the outer end is the trapezoid line, which comprises two segments: the anterior segment, which attaches to the trapezoid ligament, and the posterior segment, which is occupied by a protrusion called the conoid tubercle, which attaches to the conoid ligament.

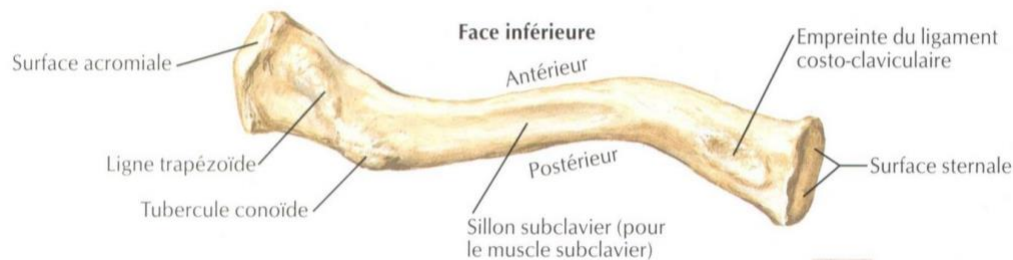


Fig. 3 : clavicule droite face inférieure.

C-BORD ANTERIEUR :

Dans ses 2/3 interne, ce bord est épais, convexe, et donne attache au muscle grand pectoral. Dans son 1/3 externe, il est concave, et présente des rugosités sur lesquelles se fixent les faisceaux antérieurs du muscle deltoïde.

D-BORD POSTERIEUR :

Ce bord est concave dans ces 2/3 internes ; en dehors il est convexe et donne attache au muscle trapèze.

E-EXTREMITÉ EXTERNE :

Cette extrémité est aplatie de haut en bas, elle présente une facette articulaire allongée, taillée en biseau et repose sur la surface articulaire de l'acromion.

F-EXTREMITÉ INTERNE :

C'est la partie la plus volumineuse de l'os, présente une facette articulaire triangulaire qui répond à la surface articulaire formée par le sternum et le premier cartilage costal.

ANTERIOR BORDER:

In its inner two-thirds, this border is thick, convex, and attaches to the pectoralis major muscle.

In its outer third, it is concave and has rough areas to which the anterior bundles of the deltoid muscle attach.

D-POSTERIOR EDGE:

This edge is concave in its inner two-thirds; on the outside, it is convex and provides attachment for the trapezius muscle.

E-EXTERNAL END:

This end is flattened from top to bottom, has an elongated, bevelled articular facet, and rests on the articular surface of the acromion.

F-INTERNAL END:

CLAVICULE

This is the largest part of the bone, with a triangular articular facet that corresponds to the articular surface formed by the sternum and the first costal cartilage.

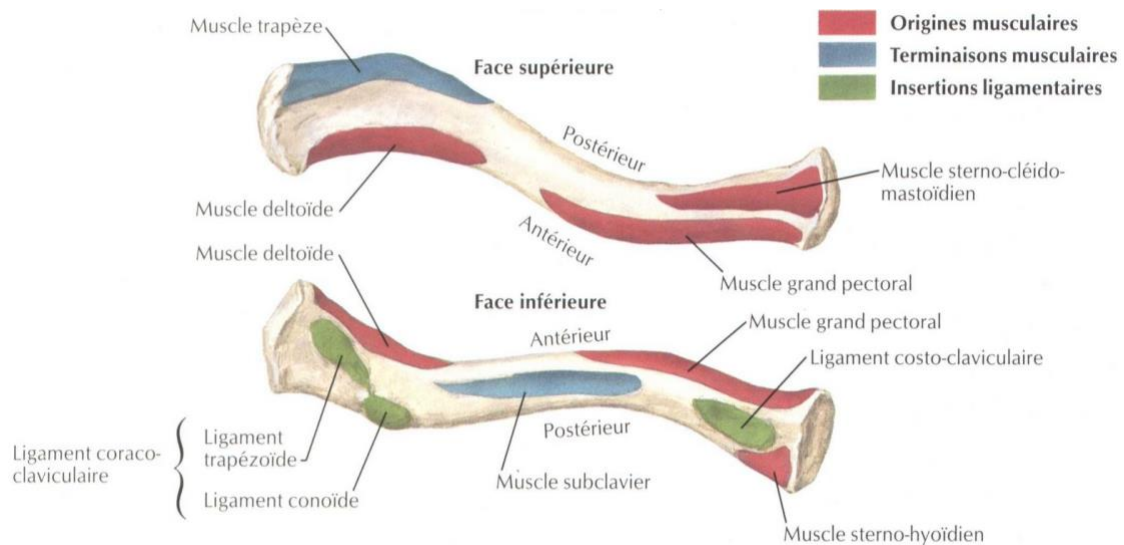


Fig. 4 : *clavicule droite face supérieure et inférieure avec insertions musculaires.*

INTERET CLINIQUE : la position superficielle de la clavicule en fait un des sites de fractures les plus fréquents, surtout chez l'enfant et le jeune adulte. Dans la majorité des cas, elle est fracturée en son tiers moyen et survient lors des traumatismes par choc direct.

La clavicule se situe sur le trajet de gros vaisseaux sanguins et de nerfs qui se dirigent vers le membre supérieur en passant sous son tiers interne. Les complications comme une compression ou un étirement nerveux ou vasculaire sont possibles.

CLINICAL INTEREST: *the superficial position of the clavicle makes it one of the most frequent fracture sites, especially in children and young adults. In the majority of cases, it is fractured in its middle third and occurs during direct impact trauma. The clavicle is located on the path of large blood vessels and nerves that travel to the upper limb, passing under its inner third. Complications such as compression or nervous or vascular stretching are possible.*

Références :

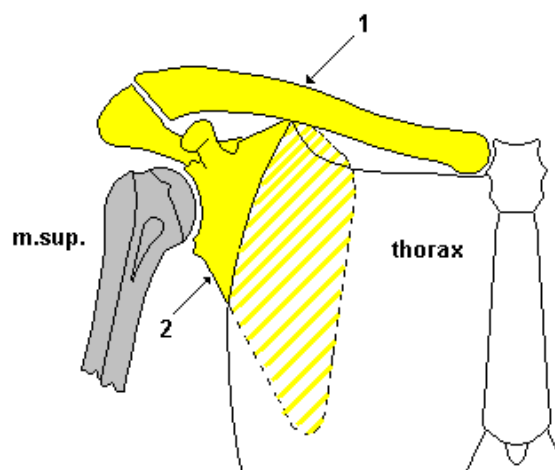
Henri Rouviere et André Delmas, Anatomie humaine, descriptive, topographique et fonctionnelle. Tome 3 membres, 15 édition, MASSON.

J.Brizon et J.Castaing, Les feuillets d'anatomie, ostéologie du membre supérieur. Fascicule I, Librairie Maloine S.A.

Si Salah Hammoudi, le cours d'anatomie, descriptive, topographique et fonctionnelle, appareil locomoteur 1 membre supérieur, Auto-édition, HS.

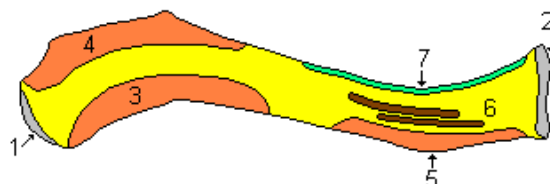
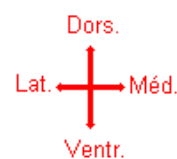
Notion de ceinture du membre supérieur

- 1- Clavicule
- 2- Scapula



La ceinture du membre supérieur est une structure ostéo - articulaire interposée entre la racine du membre et le thorax. Sa mobilité propre, par rapport au tronc, augmente, de façon importante, l'amplitude des mouvements globaux du membre (amplitude du cône de circumduction).

CLAVICULE : Face crâniale
(ou supérieure)

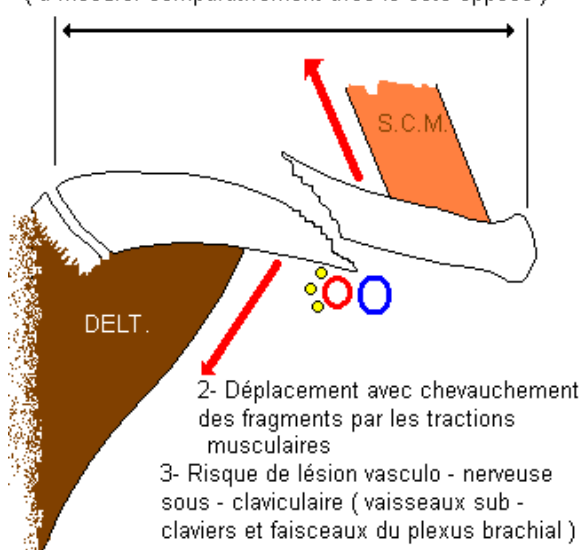


- 1- surface articulaire acromiale
- 2- surface articulaire sternale
- 3- m. deltoïde
- 4- m.trapèze
- 5- m. grand pectoral
- 6- m.sterno-cléïdo-mastoïdien
- 7- fascia cervical

La fracture de clavicule au 1/3 moyen

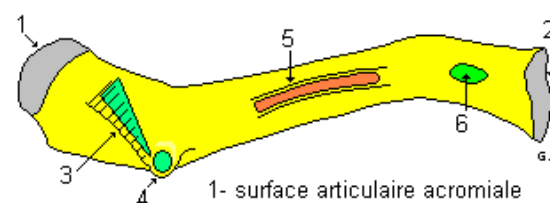
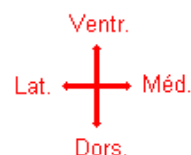
Conséquences :

- 1- Raccourcissement claviculaire
(à mesurer comparativement avec le côté opposé)



- 2- Déplacement avec chevauchement des fragments par les tractions musculaires
- 3- Risque de lésion vasculo - nerveuse sous - claviculaire (vaisseaux sub - clavières et faisceaux du plexus brachial)

CLAVICULE : Face caudale
(ou inférieure)



- 1- surface articulaire acromiale
- 2- surface articulaire sternale
- 3- ligne trapézoïde et ligament trapézoïde
- 4- tubercule conoïde et ligament conoïde
- 5- sillon du m. sub-clavier avec l'insertion du muscle
- 6- ligament costo-claviculaire

FIN

CLAVICULE